# كراس
# الكشف المبكر
# لذوي الاعاقة البصرية
# والوقاية من العمى


**ابتسام عبد هامل**

**تقنيات طبية/بصريات**

**معاون مدير برنامج الوقاية من العمى**

**وضعف البصر في العراق**

**الدكتور**

**زيد عبد النافع**

**مدير برنامج الوقاية من العمى**

**وضعف البصر في العراق**

## ضعاف البصر :

ان فقدان البصر ( العمى ) له عواقب انسانية ، اجتماعية ، اقتصادية كبيرة في جميع المجتمعات ، كما ان تكلفة خسارة الانتاج واعادة تأهيل وتعليم فاقدي البصر تشكل عبئا اقتصاديا كبيراً ، خاصة في كثير من الدول النامية ، يضاف الى ذلك انه في مثل هذه الاوضاع فان العمى عادة ما يرتبط بانخفاض الامل والتوقعات المستقبلية ، وهكذا ( فان منع العمى ، وفقدان البصر ومعالجته) يمكن ان يوفر توفيرا اجتماعيا وماديا كبيرا ويؤدي الى تسهيل التنمية الاجتماعية .

**تعاريف**

١. **حدة البصر:** هي قدرة العين على تمييز شكل وتفاصيل الاجسام فالعين السوية هي التي تستطيع ان تركز اشعة الضوء الساقطة عليها في بؤرة حادة في شبكية العين تدعى الشائبة الصفراء

٢. **ضعف البصر** : هو قلة حدة البصر والمكتشف على لوحة فحص البصر باقل من ١٨/٦ وفي كلتا العينين وبعد التصحيح بالنظارات .

٣. **العمى** : ان عدم القدرة على عد الاصابع من بعد ثلاثة امتار يعتبر فاقدا للبصر



الإعاقة البصرية من الإعاقات النادرة التي تصيب الأطفال وتؤثر بشكل كبير على حياتهم خصوصا في مراحل النمو المبكرة كما تؤثر بشكل كبير على العلاقة المتبادلة بين الطفل وعائلته وتؤثر أيضا على النواحي الاجتماعية والعاطفية المتعلقة بالطفل.

## مفهوم الاعاقة البصرية Visual Impairment

تعرف الاعاقة البصرية بانها حالة من الضعف في حاسة البصر، بحيث يحد من قدرة الفرد على استخدام هذه الحاسة بفعالية واقتدار ، الامر الذي يؤثر سلبا في نموه وادائه.

## تصنيفات الاعاقة البصرية

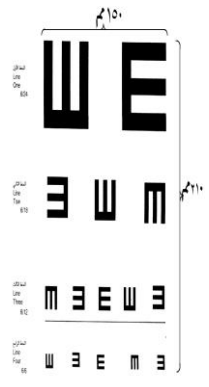
قد يولد الافراد المعوقين مصابين بالإعاقة البصرية بشكل كلي او جزئي في مراحل حياتهم . وان الاطفال الذين يفقدون ابصارهم قبل سن الخامسة لا يحتفظون بصورة بصرية مفيدة . والاطفال الذين يفقدون ابصارهم اثناء السنوات المبكرة كليا او جزئيا بعد سن الخامسة قد يحتفظون باطار بصري جيد ويستطيعون تكوين فكرة بصرية عن هذا الشيء خاصة الاعتماد على خبراتهم البصرية السابقة، على الرغم من ان ملاحظتهم البصرية محدودة ويعتمد على ما تبقى لديهم من ابصار.

ويمكن القول ان الاعاقة البصرية يمكن ان تصنف الى مايلي:

- فقد بصر تام ولادي او مكتسب قبل سن الخامسة .
- فقد بصر تام ، مكتسب بعد سن الخامسة.
- فقد بصر جزئي مكتسب .
- ضعف بصر ولادي .
- ضعف بصر مكتسب.

**تصنيف منظمة الصحة العالمية لضعاف البصر**

| من | الى | التشخيص* |
|---|---|---|
| ٦/٦ | ١٨/٦ | طبيعي |
| < ٦/١٨ | ٦/٦٠ | ضعف بصر |
| <٦/٦٠ | ٣/٦٠ او عد الاصابع من بعد ٣ امتار | ضعف بصر شديد |
| <٣/٦٠ | عدم التحسس بالضوء | الاعمى |



- **درجة الرؤية مع التصحيح بالنظارات**
- **اقل من ١٠ درجات ( الرؤيا المركزية ) يساوي العمى**
- **6/18 > الى 3/60 يدعى احيانا البصر الضعيف low vision**

## الكشف والتدخل المبكر مع الإعاقة البصرية

إنه لمن السهل جدا أن يكتشف بأن هذا الشخص كفيف ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في معرفة الأشخاص ضعيفي البصر إذ أن الأسباب المؤدية لهذا الضعف هي أسباب متعددة وفي بعض الأحيان قد لا تكون ظاهرة.

## مسؤولية الكشف المبكر

إن الكشف المبكر عن ضعف البصر الشديد في مرحلة الطفولة هو مسؤولية كل من:
١-الأسرة.
٢- معلمات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
٣- الأطباء.

### أعراض الإعاقة البصرية:

هناك مجموعة من الأمراض تشير إلى احتمال معاناة الطفل من مشكلة بصرية فقد قامت الجمعية العالمية لطرق الوقاية من الإعاقة البصرية بوضع قائمة للأعراض التي تظهر عند بعض الأطفال ويجب أن ينتبه لها الأهل في البيت والمعلم في المدرسة حيث يمكن للأسر ولمعلمات رياض الأطفال ملاحظة بعض الأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة ما في قدرة الطفل على الإبصار ومن هذه الأعراض ما يلي:

**أنواع الشكوى:**

١- الآم العين وآلام العين في الضوء.
٢- الاجسام الطائرة
٣- الرؤية المزدوجة والضبابية والخلط بين الحروف المتشابهة.
٤- إصابة العين بحكة ، أو حرقة ، أو الشعور بوخزات والشعور بالألم.
٥- عدم وضوح الرؤية
٦- صعوبة في الحكم على المسافات
٧- النظر الى الاشياء من مسافات قريبة جداً.
٨- الاصطدام بالأشياء الصغيرة
٩- فقدان الموقع الذي وصل اليه الشخص اثناء القراءة
١٠- الصداع بعد إنجاز عمل يتطلب جهد عن قرب أو الغثيان.
١١- الدوخة عند القراءة أو الكتابة الشعور بوجود شيء خشن أو رمل في العين.
١٢- عدم الاهتمام بالأنشطة البصرية.
١٣- اتجاه الحدقتين الى الداخل والخارج والاعلى والاسفل
١٤- صعوبات في التركيز والمتابعة البصرية

## سلوك الطفل المعاق بصرياً:

- تسقط منه بعض الكلمات أو السطور عند القراءة أو يقرأ ببطء.
- تقطيب الجبين مع تكرار رمش العين عند محاولة تركيز النظر كما في القراءة.
- تقريب الكتب والأشياء الأخرى من عينه أكثر من اللازم.
- دعك العين باستمرار كأنه يحاول إزاحة الضباب بعيدا عن عينه

- يغطي إحدى عينيه أو يميل برأسه عند النظر إلى الأشياء.

- يشعر بالتعب ويميل إلى النعاس وغالبا ما يظهر ميلا إلى العصبية بعد قيامه بالقراءة مدة طويلة ، أو بالأعمال التي تتطلب النظر عن قرب.

- تتعثر قدمه بالأشياء الصغيرة.

-لا يتفوق في الألعاب التي تتطلب النظر سواء عن قرب أو من مسافات بعيده.

- قد يكون لديه حساسية للضوء ، كما أن تمييزه للألوان قد يكون ضعيفا.

- يواجه صعوبات في دراسته نتيجة لقصور حاسة البصر عنده.

## وجدير بالذكر أن الهدف الأساسي من الكشف والتدخل المبكر:-

هو الوقاية من وجود مسببات ضعف البصر ، ثم الاكتشاف إن وجد ، ثم التدخل المناسب للحيلولة دون تدهور الحالات التي لا يتم اكتشافها مما يؤدي إلى نتائج سلبية تزيد كلما تأخر التدخل.

## الأعراض الظاهرية:

-انتفاخ الجفون والتهاب الجفون.
-احمرار العينين.
-الإحساس بتنمل في العين باستمرار
- سيلان الدمع وانتفاخ الجفون.
- حكة العينين بشكل متكرر.
- تكرار ظهور شعيرات الجفن ووجود قشرة.
- الحول سواء الدائم أو المتكرر.

**ومن الأعراض أيضا ما قد يلاحظه المعلم في الصف مثل:**

- تفضيل الواجبات والأنشطة التي لا تتطلب التعامل مع العين مثل الاستماع.

- عدم الاهتمام بالأنشطة البصرية مثل النظر إلى اللوح أو القراءة

-كثرة التعرض للسقوط أو الاصطدام

-الحذر الشديد عند نزول الدرج

-الخلط بين الأشياء والحروف والأرقام المتشابهة

إذن بعد أن يتم ملاحظة واحدة أو أكثر من الدلائل على الطفل فإنه يحوّل إلى فاحصي البصر و أخصائي العيون الذي يقوم بإجراء الفحص الدقيق على عين الطفل وذلك لتحديد درجة ونوع الإعاقة البصرية وأسبابها واحتمالات تطورها. بالإضافة إلى أخصائي العيون فإنه يتم تحويل الطفل إلى كل من أخصائي الأطفال لتحديد مدى تأثيرها على النمو الجسمي والأخصائي النفسي لتحديد مدى تأثيرها على الذكاء كذلك أخصائي السمع والتخاطب لتحديد مدى تأثيرها على التواصل.

قد يشخص أخصائي العيون حالة الطفل على أنها من النوع القابل للعلاج أو التصحيح وذلك من خلال تدريب عضلات العين، أو من خلال الجراحة أو من خلال العدسات أو النظارات الطبية التي تساعد على الرؤية بشكل طبيعي وفي هذه الحالة فإن هذا الطفل لا يحتاج إلى برامج تربوية خاصة أما إذا كانت حالة الطفل من النوع المتطور أو غير القابل للعلاج أو التصحيح فإن الطفل يكون بحاجة إلى الانخراط في برامج التربية الخاصة.

**تعليمات حول قياس حدة البصر:-**





١. توضع لوحة الفحص على الحائط وبنفس مستوى النظر في غرفة مضيئة مقابل الشباك وليس بجانبه لان الضوء سوف يلمع في عين الطالب المفحوص ويؤثر على الفحص .

٢. يجب ان يقف الشخص على بعد ستة امتار من اللوحة او ثلاثة امتار في حالة وجود مرآة وتثبت لوحة الفحص خلف الشخص. ابدا بالفحص دائما بالعين اليمنى ، ثبت النتيجة ، ثم افحص العين اليسرى .

٣. غط العين الثانية بورقة سميكة او براحة اليد( اذا كانت نظيفة ) مع مراعاة عدم الضغط الشديد .

٤. التأشير اسفل الحرف المراد معرفته بعصا او قلم مغاير للون اللوحة ويجب ان يؤشر الشخص بيده على اتجاه الحرف او الفتحة ولا تعتمد على كلمة يمين او يسار لان الشخص يخطأ بين اليمين واليسار

٥. كن صبورا ومشجعاً للشخص اثناء الفحص ، معظم الاطفال والتلاميذ يخافون الفحص كما في الامتحان او خوفا من النظارات يحاولون الغش والنظر خلال الاصابع ، قرب الطالب من اللوحة واشرح له الموضوع ابدا دائما من الحرف الكبير وانزل تدريجيا فهو اسهل للنظر وحتى يتعود الطالب على الفحص ثم رجع الطالب الى مسافة ستة امتار .

٦. لتثبيت حدة البصر يجب ان يرى اكثر من نصف الاحرف في السطر ، وان رأى اقل من نصف الاحرف ثبت درجة السطر الذي سبقه .

٧. الدرجة ٦/٦ البسط ثابت ويمثل المسافة ستة امتار بين الطالب واللوحة ، اما المقام فهو متغير حسب قوة النظر .

٨. بالرغم من ان حدة البصر التي ١٨/٦ تعتبر طبيعي حسب التصنيفات العالمية لكنه يحتاج احالة لفحص العوينات والنظارات الطبية وقياس قوة العدسة.

٩. اسال الاهل عن الطلاب الذين يعانون من تعب العين اثناء القراءة وحرقة وتدمع وترمش الاجفان واحتقان المنظمة وظهور دمامل متكررة في الاجفان ، صعوبة في رؤية السبورة والتلاميذ الذين لديهم نظارات طبية ولا يستخدمها .

١٠. اخطاء الانكسار والحول الذي يصيب عين واحدة ان لم تعالج قبل السابعة من العمر سوف يؤدي الى كسل وظيفي في العين المصابة ولا يمكن الحصول على نظر طبيعي بعد ذلك .يجب ان نتذكر بان الفحص بواسطة لوحة فحص البصر يمثل فحص الرؤية البعيدة .

١١. في حالة استعمال لوحة فحص البصر من المستحسن صنع حرف مماثل من الخشب او غيرها لتعليم الطالب كيفية توجيه فتحة الحرف حسب الصورة الموجودة على اللوحة .

١٢. اذا كان الطالب مرتديا النظارات الطبية فمن المستحسن فحصه اولا بالنظارات ثم بدون النظارات .

١٣. يجب ان يكون الضوء اثناء الفحص كافيا ولوحة فحص البصر غير لامعة ولا تسبب تعب في الرؤية.

١٤. اخطاء الانكسار والحول الذي يصيب عين واحدة ان لم تعالج قبل السابعة من العمر سوف يؤدي الى كسل وظيفي في العين المصابة ولا يمكن الحصول على نظر طبيعي بعد ذلك .

**<u>الاعراض التي تدلنا على وجود خطأ انكساري</u>**



١. فرك الشخص او الطالب عينيه في اكثر الاحيان .

٢. يحاول الطالب ان يغمض عينيه ويفتحها لمشاهدة الصور بوضوح .

٣. لا يرتاح لعدم تمكنه من مشاهدة الكتابة على السبورة او الخرائط او الصور .

٤. يتهيج ويصرخ بعض الاحيان عندما لا يرى بوضوح .

٥. عندما ينظر إلى الاشخاص او المناظر البعيدة يأخذ الوضع التالي :-

- يضغط على نفسه ليرى الصورة.
- يقطب وجهه. يقدم رأسه إلى الامام

**اثناء القراءة**



١. يرمش جفنيه .
٢. يمسك الكتاب بعيدا عن الوجه .
٣. يمسك الكتاب قريبا عن الوجه .
٤. يحاول ابعاد وتقريب الكتاب محاولة منه للرؤية بوضوح .
٥. يظهر على الطالب عدم الراحة اثناء الدرس .
٦. يبتعد عن الدرس بفترات .
٧. يغمض عينيه او يغطيها بيديه بعض الاحيان .
٨. يحرك رأسه إلى احدى الجهات .
٩. لا يرى بعض الحروف او الكلمات اثناء القراءة.
١٠. عينيه تنحرف بصورة غير طبيعية .
١١. يحاول تبديل وضع الكتاب ليرى بوضوح

## المراحل الرئيسية في عملية تقييم الأطفال المعوقين بصريا الصغار في السن






**التقييم الطبي:**

١- الفحص الطبي العام.
٢- الاختبارات الطبية الكشفية.
٣- الفحوصات الطبية التفصيلية.

**التقييم البصري:**

١- فحص العيون.
٢- تقييم البصر الوظيفي
٣- تقييم الفاعلية البصرية

**التقييم الاجتماعي:**

١- التاريخ التطوري للطفل
٢- موقف الوالدين من الإعاقة

**تقييم المهارات الوظيفية:**

١- مهارات الحياة اليومية.
٢- مهارات التعرف والتنقل .

## استراتيجيات التدخل المبكر للأطفال المعوقين بصريا

١- تذكر أن الوالدين أهم عنصر في حياة الطفل واي تدخل اخر إنما هو تدخل مرحلي.
٢- ضع يديك على يدي الطفل ليحس بالحركة وبالتالي يعرف ما الذي تريده منه.
٣- قف خلف الطفل وليس أمامه.
٤- تذكر أن الخبرة الحقيقية أكثر فائدة للطفل من وصف الخبرة.
٥- تذكر أن قدرة الطفل على التقليد وعلى التعلم التلقائي محدودة ولذلك فإن كثيرا من الأحداث اليومية الروتينية تحتاج إلى توضيح.
٦- تحدث مع الطفل عن كل صوت يسمعه وعن كل حركة يقوم بها.
٧- يجب أن يتم التدريب البصري على نحو وظيفي متسلسل.
٨- خفف المساعدة التي تقدمها للطفل ليتعلم الاعتماد على نفسه.

٩- كن ثابتا واستخدم المصطلحات نفسها حتى لا تربك الطفل.
١٠- استخدم البديهة ، علم الطفل النشاطات في الأوقات والأماكن المناسبة والطبيعية
١١- يجب أن تتصف بالتلقائية في تفاعلك مع الطفل.
١٢- اطرح القليل من الأسئلة ، وقدم الكثير من الأجوبة واستمع جيدا.
١٣- خصص وقتا كبيرا للتواصل اللمسي مع الطفل (احمله ، عانقه ، هز جسمه) واستخدم الأصوات الدافئة والمطمئنة.
١٤- احتفظ بسجلات مناسبة حول نمو الطفل ونضجه.
١٥- زود الطفل بتغذية سليمة.

## اساليب تدريس الاطفال المعوقين بصرياً

ان اساليب تدريس المعوقين بصريا تعتمد على شدة الاعاقة ، والاعاقات المرافقة لها، ومن هذه الطرق والتي تهدف الى تعليمهم مهارة الحركة والقراءة والكتابة بطريقة BRAILL و الابتكون Optacon واستعمال العداد الحسابي لتعليمهم الحساب .

ولتعليمهم مهارة الحركة يمكن الاعتماد على ما يلي لتحقيق ذلك :

- العصا البيضاء White cane
- عصا الليزر Lazer cane
- الدليل المبصر Human Guide
- النظارة الضوئية Sonic glasses
- الكلاب المرشدة Guide dogs
- الاجهزة الصوتية Sound systems

**ان الحركة تعتبر مشكلة بالنسبة للكفيف لذلك فان الوسائل السابقة تساعده على التكيف مع المحيط الذي يعيش فيه**

**هناك عدد كبير من الأطفال مصابون بضعف في النظر، وإن اكتشاف هذا الضعف مبكراً هو في غاية الأهمية، إذ من الممكن لأخصائي العيون أن يساعد الطفل في تقوية نظره، في سن مبكرة، وقبل أن يبلغ الثماني سنوات من عمره، وإلا تصبح العين كسولة، ولا يمكن تقوية نظرها بعد ذلك.**

**الطفل لا يعرف في العادة مدى قوة نظره ولا يشكو من ضعف فيه.**

**رسائل صحية :-**



١. جميع الاطفال يجب ان تقاس درجة الرؤية لديهم.

٢. الاطفال الذين يقربون الكتاب من وجههم عند القراءة والاطفال الذين يجلسون قريبين جدا من السبورة حتى يتمكنوا من رؤية ما مكتوب عليها. يجب على هؤلاء ان يحصلوا على فحص للعينين على الفور



٣. عندما نكبر ونتقدم في السن فان حدة البصر وقابلية الرؤية تبدا بالتغير ويصبح من الصعب رؤية الاشياء الصغيرة عندما تكون قريبة منا وهذا التغير من الممكن تصحيحه بسهولة عند ارتداء النظارة الطبية المناسبة . الاشخاص الذين هم اكبر من ٤٠ سنة من العمر يجب ان يتم فحص بصرهم دوريا.

٤. ضعف البصر تعتبر من مسببات العمى الممكن تجنبه وممكن معالجته بالنظارات الطبية التي لا تسبب ضعف للعين.

٥. يجب احترام الاطفال الذين يرتدون النظارات الطبية وعدم مضايقتهم.



٦. المحافظة على الصحة العامة من أهم وسائل المحافظة على صحة العين.

٧. التغذية السليمة والصحية المتوازنة والمتكاملة في غاية الأهمية للمحافظة على صحة وسلامة ونضارة العين خصوصا في كل من مرحلتي الطفولة والشيخوخة.

٨. حفاظا على أعينهم يمنع الأطفال من اللعب بأي آلات حادة أو مدببة مثل ألعاب السيوف حتى لو كانت مصنوعة من البلاستيك أو بأي ألعاب بها مواد قابلة للقذف والاندفاع مثل السهام والحراب والمسدسات الليزرية وذات الصجم .

٩. لا تسمح للأطفال باللهو بأي مفرقعات نارية خشية تطاير شررها أو بعض المواد الحارقة أو الصلبة منها إلى العين واجعل أي مواد كيميائية بعيدا عن متناولهم

١٠. ينصح الأطفال بعدم إلقاء الحجارة على بعضهم البعض لأن كثيرا من حالات نزيف العين وخسارتها كان بسبب ذلك.

١١. لا تكثر الجلوس أمام شاشات التلفاز والكمبيوتر ..ولا بد من الاستراحة كل (٢٠ دقيقة) بإغماض العين أو بالابتعاد عن شاشة الكمبيوتر والنظر إلى مسافات بعيدة لكي ترتاح عضلات العين من النظر المستمر للشاشة.

**المصادر**


- تدريب المعوقين في اطار المجتمع
مجموعة تدريبية لاحد افراد الاسرة /شخص يجد صعوبة في الابصار / صدرت الطبعة العربية عن المكتب الاقليمي لشرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية

- دليل تدريبي لصحة وسلامة البصر لتلاميذ المدارس الابتدائية /وزارة الصحة /دائرة الصحة العامة /مطابع دائرة العيادات الطبية الشعبية /بغداد
-
- بحث في الاعاقة البصرية / محمد مصطفى حميدة

- المدخل الى التربية الخاصة /للأطفال ذوي الحاجات الخاصة
المفهوم-التشخيص-اساليب التدريس / تأليف سعيد حسني العزة /ماجستير ارشاد وصحة نفسية /الجامعة الاردنية /٢٠٠٢